

«Гіпертонічна хвороба»

1. Завдання, що виконуються здобувачем освіти на станції:

- продемонструвати комунікативні навички (*привітатися з пацієнтом; назвати себе; запитати, як звертатися до нього; запропонувати зручно сісти; забезпечити під час бесіди ізоляцію від впливу різних подразників (сторонні розмови, телефонні дзвінки, тощо); сісти поруч за стіл*).
- спитати скарги та деталізувати їх;
- вияснити анамнез захворювання та життя;
- продемонструвати практичну навичку «Перкусія серця (визначення меж відносної тупості серця)»;
- виділити провідний синдром;
- надати рекомендації щодо профілактики та пропаганди здорового способу життя;
- продемонструвати невербальні компоненти ведення бесіди (тактовність, ввічливий тон, вираження емпатії тощо).

2. Клінічні кейси (сценарії, задачі), які відпрацьовуються на станції:

- Сценарій «Збір скарг та анамнезу, об'єктивне обстеження хворого з діагнозом гіпертонічна хвороба»
- Додаток 1. Об'єктивне обстеження

Стан відносно задовільний. Шкіра блідо-рожева, чиста. Набряків немає. У легенях – везикулярне дихання. Тони серця приглушені ритмічні, акцент 2 тону на аорті. ЧСС=Пulьс=82 за хв. АТ – 170/90 мм рт.ст на обох руках. Живіт м'який безболісний. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

3. Інформація для студента – алгоритм роботи на станції:

Ви лікар поліклініки. До Вас звернувся чоловік.

Алгоритм дій здобувача.

	Дії здобувача освіти	Текст стандартизованого пацієнта
1.ПРОДЕМОНСТРУВАТИ НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ.		
<i>Привітатися з пацієнтом</i>	Доброго дня.	Доброго дня.
<i>Представитися, позначити свою роль</i>	Я лікар-терапевт, Володимир Іванович. Я з Вами поспілкуюсь, огляну, проведу обстеження.	Добре

<i>Запитати пацієнтку, як до неї можна звертатися</i>	Як я можу до Вас звертатися?	Панас Петрович
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
<i>Уточнити вік пацієнтки</i>	Скільки Вам років?	65 років
<i>Уточнити заняттєву активність</i>	Ви працюєте?	Так, я ще працюю водієм на рейсовому автобусі.
1. ІНШЕ (В Т.Ч. ЛЕГАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ)		
<i>Отримати інформовану згоду на проведення обстеження</i>	Ви даєте свою згоду на проведення обстеження?	Так
<i>Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні</i>		
<i>Інформувати пацієнта про «лікарську таємницю»</i>	Наша розмова конфіденційна, можете мені довіритися.	Добре.
2. ЗБІР СКАРГ ТА АНАМНЕЗУ		
<i>Запитати скарги пацієнтки</i>	Панасе Петровичу, що Вас турбує?	Головний біль, запаморочення, біль за грудиною
	Опишіть будь ласка Ваш головний біль: де болить, коли починається, після чого проходить?	Голова болить у потиличній ділянці, зранку. Я вимірюю артеріальний тиск і в мене 180/90 мм рт.ст. Тоді я приймаю ліки від тиску і біль проходить, але не завжди.
	Можете розповісти про характер болю в серці, коли він виникає, скільки продовжується, після чого проходить?	Серце колить ось тут (вказати рукою на грудину). Я помітив, що серце починає колоти, коли підвищується тиск.
	Вас турбує задишка?	Ні
	Перебої в роботі серця відчуваєте?	Ні
	Як давно Ви хворієте?	2 роки

<i>Запитати анамнез захворювання пацієнтки</i>	З чим пов'язуєте початок захворювання?	Не знаю. Я проходив медичну комісію і лікар мені сказав, що у мене
		високий тиск.
	Ви приймали ліки для зниження тиску?	Спочатку ні, а потім дружина заставила приймати ліки. У неї теж високий тиск, їй лікар призначив телмісартан і гідрохлортіазид.
	Які препарати і в якій дозі Ви приймаєте цей препарат?	Телмісартан 40 мг і гідрохлортіазид 12,5 мг.
	Ви регулярно приймаєте ліки?	Останні 2 місяця регулярно.
	Що зараз Вас змусило звернутися до лікаря?	Голова не проходить.
<i>Запитати анамнез життя пацієнтки</i>	Чим хворіли протягом життя?	ГРВІ, пневмонія
	Туберкульоз, вірусні гепатити, цукровий діабет ? Операції, травми протягом життя?	Ні
	Шкідливі звички?	Палив 20 років пачку/день. 2 роки тому кинув.
	Алергійні реакції? Непереносимість ліків?	Ні
	Спадковість: хтось хворів захворюваннями серця?	Мати все життя мучилась високим тиском, померла від інсульта.
	ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:	
<i>Попросити пацієнта зняти одяг</i>	Будь ласка звільніть від одягу верхню половину тулуба, я проведу Вам перкусію меж відносної тупості серця	Так, зараз.
4. ОБ'ЄКТИВНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА Додаткова інформація об'єктивного обстеження пацієнта надається здобувачу у паперовому вигляді.		

Продемонструвати практичну навичку «Перкусія серця»	<u>Перкусія правої межі відносної тупості серця</u> по відповідним лініям: палець-плесиметр ставлять в III міжребер'ї	Коли здобувач освіти буде перкутувати в IV міжребер'ї на 1 см назовні від правого краю грудини
(визначення меж відносної тупості серця)»;	паралельно ребрам по правій серединно-ключичній лінії, використовують голосну перкусію й просуваються вниз до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого (легені) до тупого звуку (печінка) У нормі нижня межа правої легені перебуває в VI міжребер'ї. Палець-плесиметр пересувають на міжребер'є вище, міняють його положення, тобто ставлять паралельно до грудини. Змінюється сила перкусії – тиха, топографічна. Перкусія проводиться в напрямку грудини до зміни перкуторного звуку від ясного легеневого до притуплення.)	– треба зупинити його, сказати «Притуплення».
	<u>Перкусія верхньої межі відносної тупості серця</u> по відповідній лінії: палець-плесиметр необхідно покласти в I міжребер'є по лівій біля грудинній лінії й перкутувати вниз до зміни перкуторного звуку	Коли здобувач освіти буде перкутувати в III ребро по лівій біля грудинній лінії.– треба зупинити його, сказати «Притуплення».
	<u>Перкусія лівої межі відносної тупості серця</u> по відповідній лінії: знайти верхівковий поштовх, який співпадає з лівою межею. Перкусію починають у тому ж міжребер'ї, у якому перебуває верхівковий поштовх, починаючи з лівої середньо-пахвової лінії. Палець-плесиметр розташовують паралельно грудині й уздовж міжребер'я перкутують у напрямку до грудини до притуплення	Коли здобувач освіти буде перкутувати в V міжребер'ї на 1,5 см назовні від лівої серединно-ключичної лінії – треба зупинити його, сказати «Притуплення».
	Межі відносної тупості серця розширені ліворуч на 2,5 см.	
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		

	Як Ви себе почувасте, все добре? Одягайтеся.	Так.
--	---	------

	Панасе Петровичу, на жаль Ваш артеріальний тиск підвищений, незважаючи на те, що Ви приймаєте антигіпертензивні препарати. Я рекомендую Вам подальше обстеження, уточнення діагнозу і коригування антигіпертензивної терапії.	
5. ВИДІЛИТИ ПРОВІДНИЙ СИНДРОМ		
	Провідний синдром у пацієнта – артеріальна гіпертензія	Зрозумів. Що ж тепер робити?
6. ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ		
	Спочатку хочу наголосити на тому, що крім регулярного прийому ліків, треба відкоригувати спосіб життя: Скоротити малорухомий спосіб життя та доповнити динамічними фізичними вправами (2-3 рази на тиждень). Відмовитися від шкідливих звичок. Дотримуватися дієти.	<i>Дякую, лікарю.</i>
ПРОДЕМОНСТРУВАТИ КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ:		
	Панасе Петровичу, чи Вам все зрозуміло?	Все зрозуміла
	Можливо у Вас є запитання до мене?	Немає
	Якщо Вам все зрозуміло і немає до мене більше питань, я дякую Вам за спілкування. До зустрічі.	Вам дякую лікарю, до зустрічі.